



RICARDINA CORREIA

PSICOLOGIA PEDIÁTRICA

Maturação cortical na PHDA

Nota científica · os dados e os limites

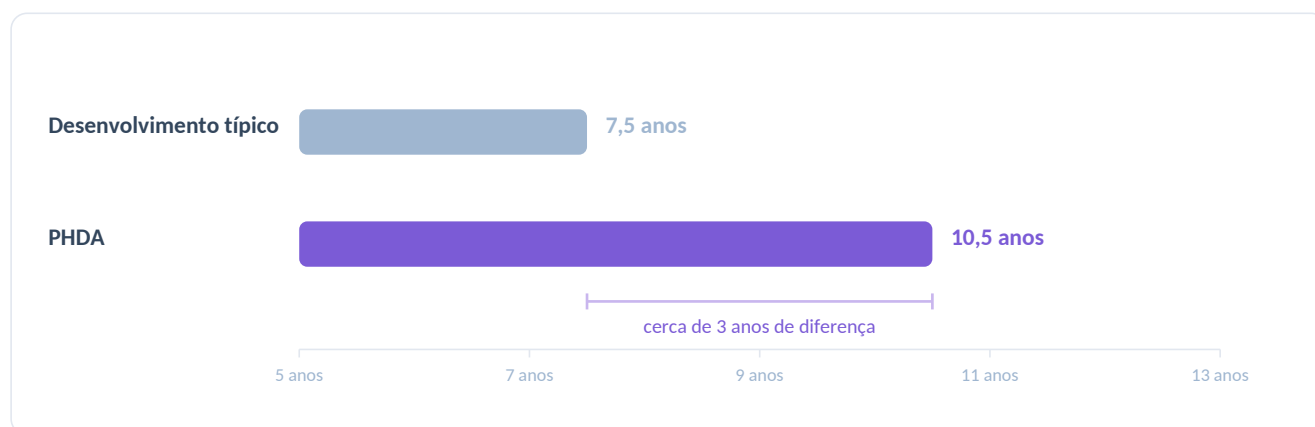
Ouve-se com frequência que «o cérebro amadurece mais tarde». A afirmação tem base num estudo concreto, com dados concretos — e com limites que raramente são referidos quando a frase é repetida. Esta nota apresenta ambos.

O estudo

Shaw P. e colaboradores (2007), «Attention-deficit/hyperactivity disorder is characterized by a delay in cortical maturation», publicado nos Proceedings of the National Academy of Sciences. Estudo longitudinal do National Institute of Mental Health, com 223 crianças e adolescentes com diagnóstico de PHDA e 223 em desenvolvimento típico. Foram analisadas 824 ressonâncias magnéticas, com estimativa da espessura cortical em mais de 40 000 pontos do cérebro.

A medida usada foi a idade em que cada ponto do córtex atinge a sua espessura máxima — o momento em que o espessamento da infância dá lugar ao afinamento que se segue à puberdade.

O resultado



A idade mediana em que metade dos pontos corticais atingiu a espessura máxima foi de 10,5 anos no grupo com PHDA e de 7,5 anos no grupo de desenvolvimento típico.

O atraso foi mais acentuado nas regiões pré-frontais — as que sustentam o controlo da atenção, a inibição e o planeamento motor. No córtex pré-frontal médio a diferença chegou aos cinco anos; noutras regiões pré-frontais foi de cerca de dois. O córtex motor primário foi a única área a amadurecer ligeiramente mais cedo no grupo com PHDA.

O que o estudo mostra

- A sequência de maturação é a mesma nos dois grupos — as áreas sensoriais primárias amadurecem antes das áreas de associação. Muda o calendário, não a ordem.
- A diferença é sistemática e concentra-se precisamente nas regiões associadas às funções que estão comprometidas na PHDA.
- Isto apoia a leitura de atraso de maturação, e não de desvio do percurso típico.



RICARDINA CORREIA

PSICOLOGIA PEDIÁTRICA

Maturação cortical na PHDA

Página 2 • o que o estudo não mostra

Os limites — e são importantes

São dados de grupo, não de indivíduo.

Descrevem uma diferença entre médias de dois grupos de mais de duzentas pessoas. Não permitem dizer nada sobre o cérebro de uma criança em concreto, nem prever o seu percurso.

Não serve para diagnosticar.

A ressonância magnética não é, nem passou a ser, um exame de diagnóstico da PHDA. O diagnóstico continua a ser clínico, feito a partir da história, da observação e da informação de mais do que um contexto.

Atraso não é garantia de recuperação.

«Amadurece mais tarde» não significa «vai passar». Uma parte das crianças mantém dificuldades significativas na idade adulta, e o estudo não permite prever quem.

Não justifica esperar.

É o uso indevido mais frequente desta informação. O atraso de maturação não é razão para adiar apoio: é razão para o dar durante o período em que a diferença existe, que é precisamente a idade escolar.

É uma medida entre muitas.

A espessura cortical é um indicador estrutural. Não capta funcionamento, nem substitui os dados clínicos e comportamentais em que assenta a compreensão do caso.

Para que serve saber isto

Não muda o que se faz. Muda a forma como se lê o que se vê: a diferença entre uma criança que não quer e uma criança cujo sistema de controlo está a chegar mais tarde. É essa leitura que sustenta a paciência necessária para aplicar, durante meses, as estratégias que funcionam.

Referência: Shaw P., Eckstrand K., Sharp W., Blumenthal J., Lerch J. P., Greenstein D., Clasen L., Evans A., Giedd J., Rapoport J. L. (2007). Attention-deficit/hyperactivity disorder is characterized by a delay in cortical maturation. PNAS, 104(49), 19649–19654.

Utilização livre, sem alteração e sem fins comerciais. Não substitui avaliação nem acompanhamento profissional.